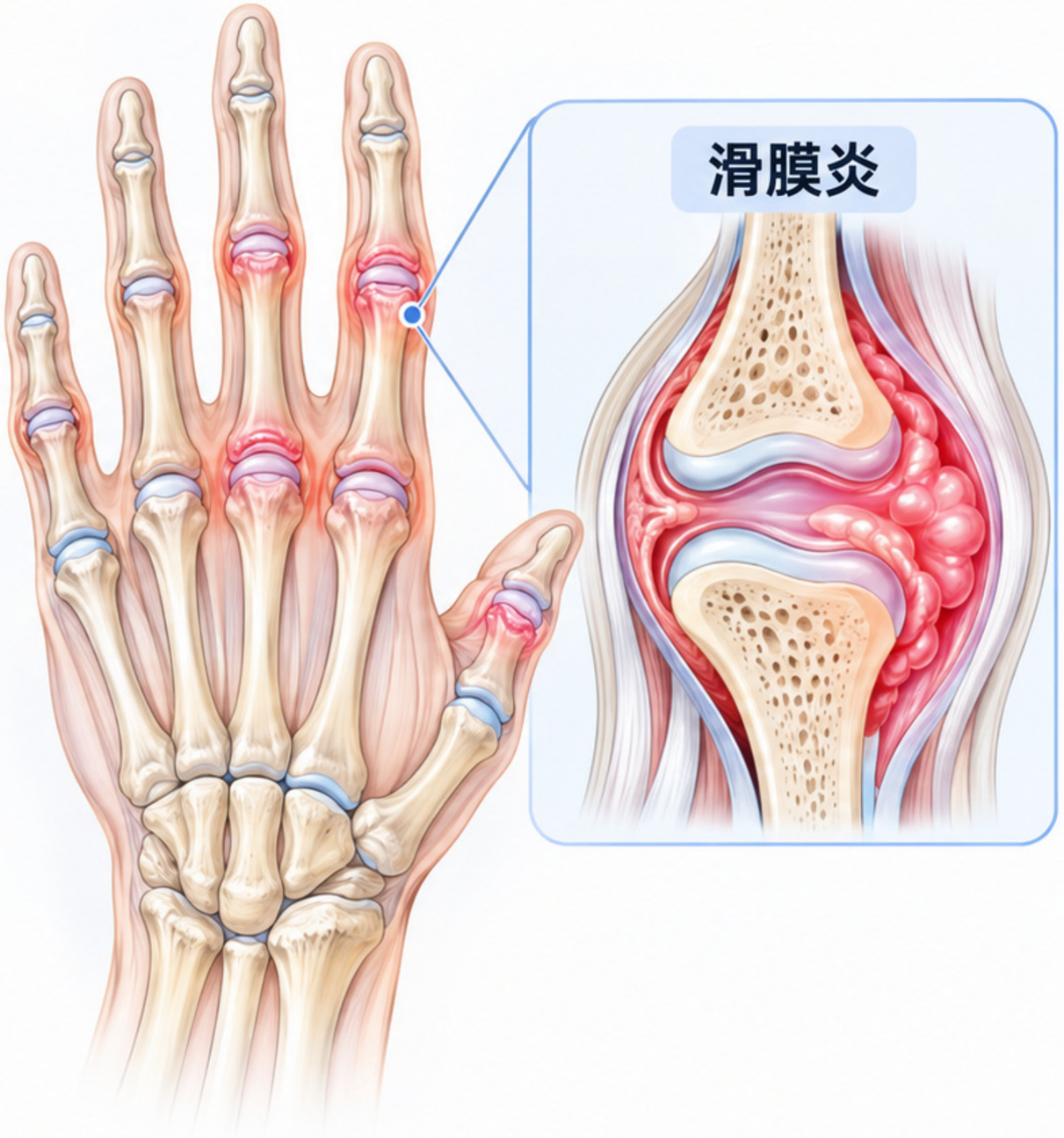
类风湿关节炎

从早期识别到规范治疗

临床医学专业四年级

识别滑膜炎，建立诊疗思路



学会四件事：识别、解释、判断、处置

以病例串联临床思维



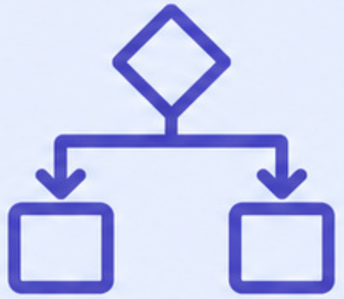
识别：

典型关节分布与
炎症性线索



解释：

抗体、炎症指标
和影像学的价值



判断：

分类标准的适用
前提与鉴别诊断



处置：

早期DMARD、
达标治疗与安全监测

双手晨僵与肿胀，首先考虑什么？

教学病例A｜先看临床，再看抗体

病例资料

- 女性，42岁；双手关节肿痛3个月，晨僵约90分钟
- 双侧第2、3掌指关节肿胀、压痛，共4个关节
- 活动后稍缓解；无明确外伤史



4个
掌指关节

A 骨关节炎

B 类风湿关节炎

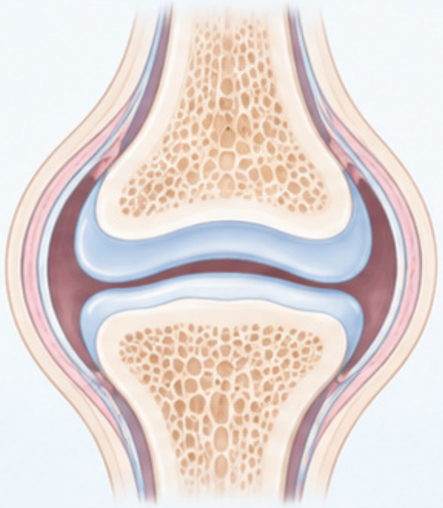
C 痛风

D 感染性关节炎

RA的核心是持续性滑膜炎

一种可导致关节破坏的系统性自身免疫病

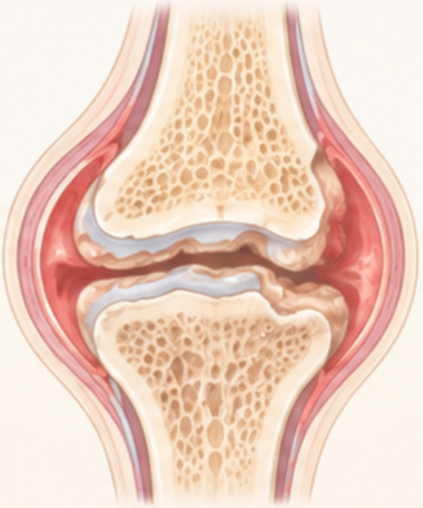
正常关节



持续性滑膜炎



结构损伤



功能障碍





- 常表现为对称性、多关节、小关节受累



- 可出现关节外表现，女性更常见



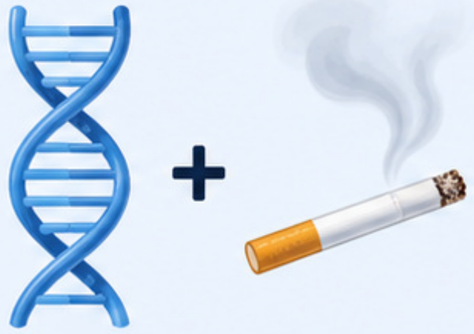
- 炎症持续可进展为结构损伤和功能障碍

免疫失衡把易感背景转化为滑膜炎

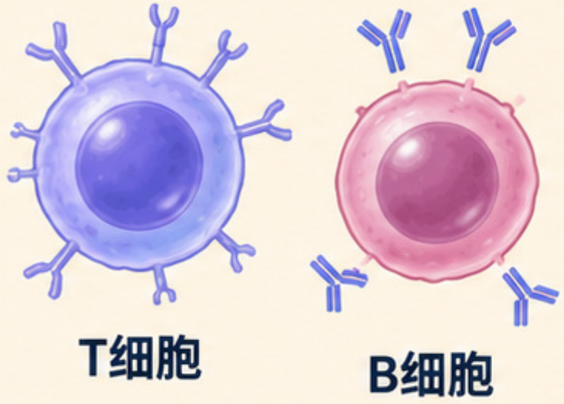
理解主线，不堆砌通路

- 遗传易感与环境因素共同作用
- T细胞、B细胞及炎症因子参与
- 持续免疫炎症推动关节组织损伤

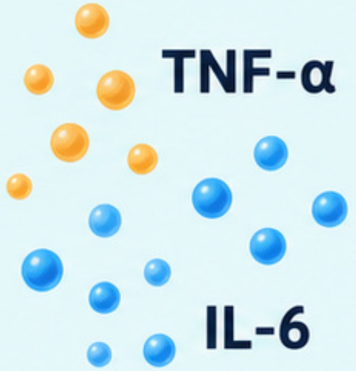
遗传易感与环境因素共同作用



T细胞、B细胞及炎症因子参与



炎症因子

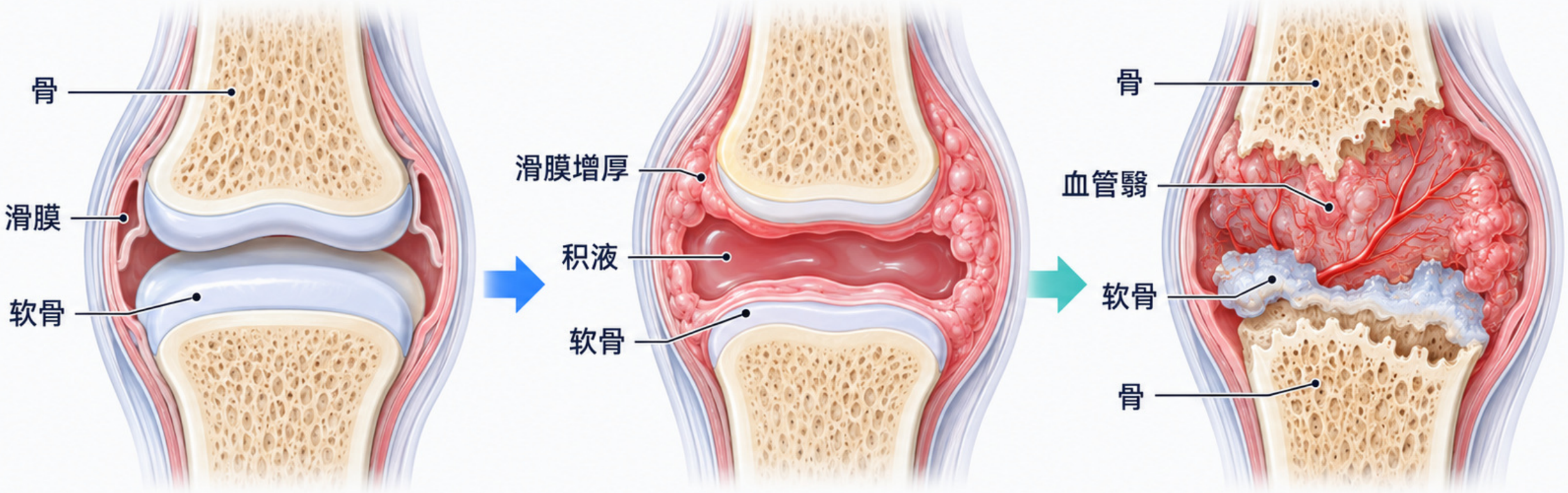


滑膜炎



血管翳解释了关节为什么会受损

从正常关节到侵蚀性病变



正常

- 薄层滑膜与完整软骨

活动性炎症

- 滑膜增厚、细胞浸润、积液

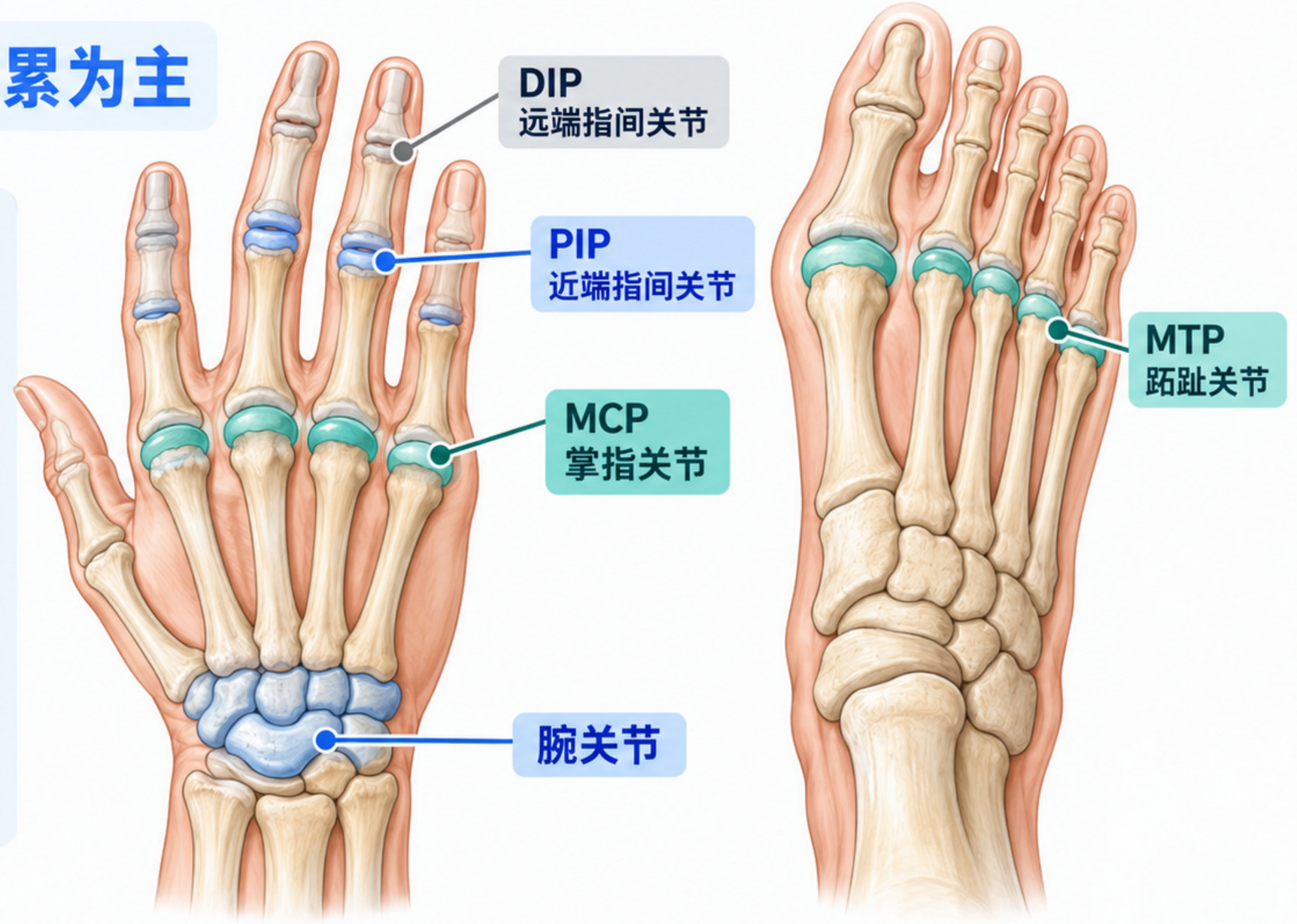
持续炎症

- 血管翳形成，侵蚀软骨与骨

先看分布：MCP、PIP、腕和MTP

典型RA以小关节受累为主

- MCP：掌指
  PIP：近端指间
- 腕关节、MTP跖趾
  关节也常受累
- DIP远端指间关节
  在典型RA中相对少见

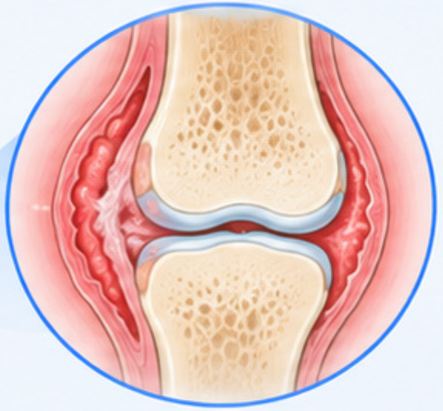


抓住炎症性关节痛的线索

与机械性疼痛进行模式比较

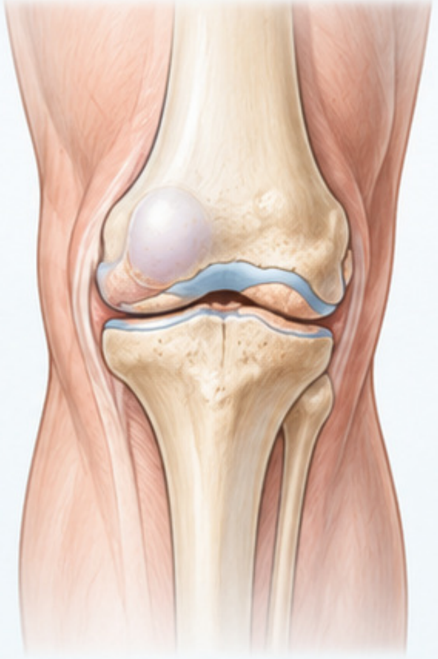
炎症性关节痛





- 晨僵**较久**
- 软组织**肿胀**
- 活动**可缓解**

机械性关节痛



- 负重或活动**加重**
- 休息常**缓解**

晨僵、肿胀、压痛与功能受限需综合判断

模式提示不能单独确诊

识别畸形，更要避免等到畸形才诊断

用关节运动方向区分三种经典形态

尺侧偏斜

掌指关节向尺侧偏移

MCP → 尺侧

尺侧＝小指侧

天鹅颈

PIP 过伸 ↑

近端指间关节向背侧

DIP 屈曲 ↓

远端指间关节向掌侧

纽扣花

PIP 屈曲 ↓

近端指间关节向掌侧

DIP 过伸 ↑

远端指间关节向背侧

早期诊断不需要等待关节畸形出现。

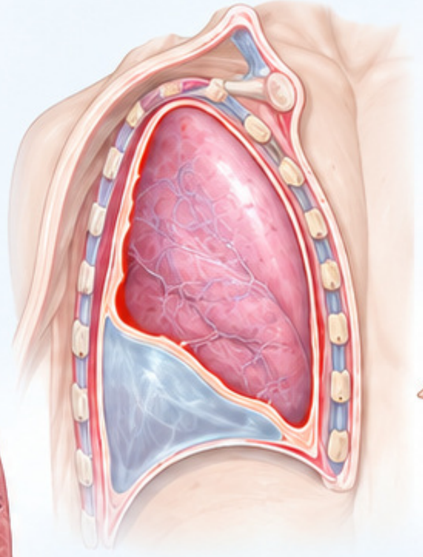
RA不只累及关节

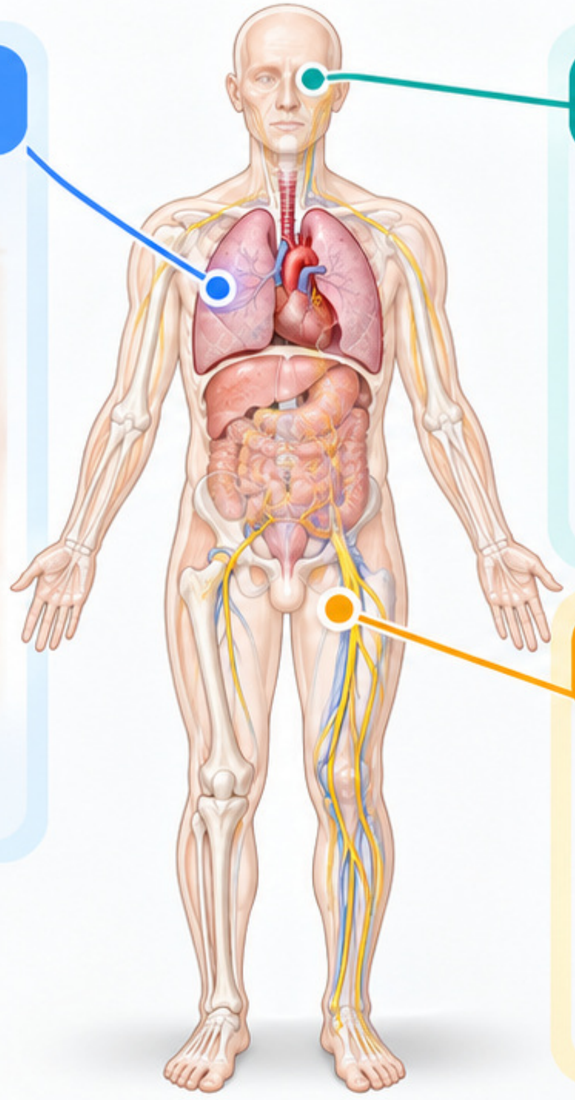
出现系统症状，要主动寻找关节外受累

肺

- 间质性肺病
- 胸膜病变

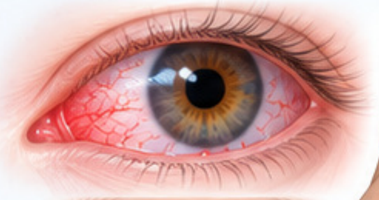






眼与皮肤

- 巩膜炎
- 干燥症状
- 类风湿结节

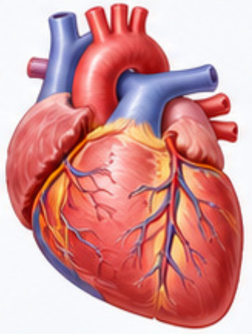






其他

- 贫血
- 心血管风险
- 神经受压等

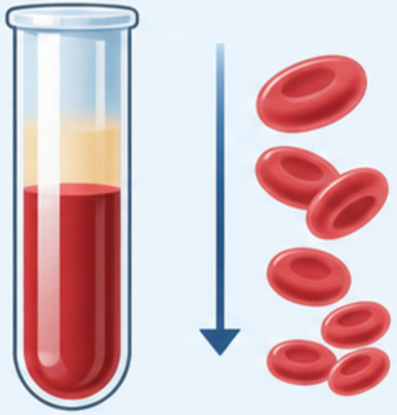




ESR和CRP反映炎症，不特异指向RA

用来支持判断与随访，而非单独确诊

ESR（红细胞沉降率）

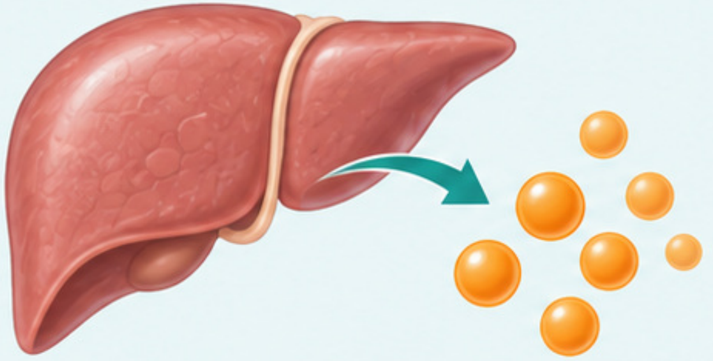


- ESR受炎症、贫血、年龄等因素影响



临床判断与随访

CRP（C反应蛋白）



- CRP可随炎症和感染等变化

升高不等于RA；正常也不能单独排除RA

RF与抗CCP要放回临床情境

抗体阳性不是确诊，阴性也不是排除

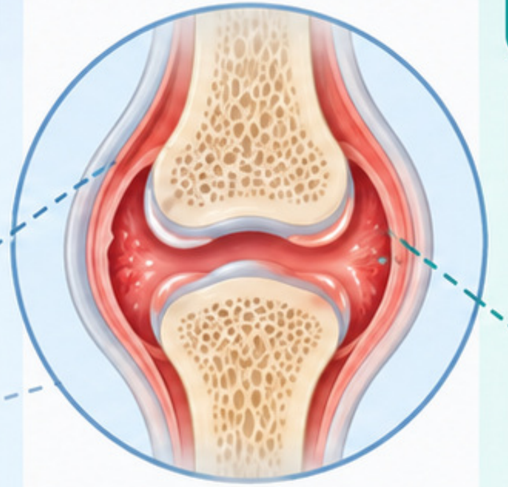
RF

RA中常见，但特异性有限



RF



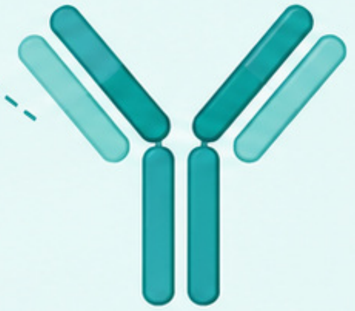


滑膜炎

结合滑膜炎、病程
与其他证据解释

抗CCP

属于ACPA，特异性通常较高



抗CCP
(ACPA)



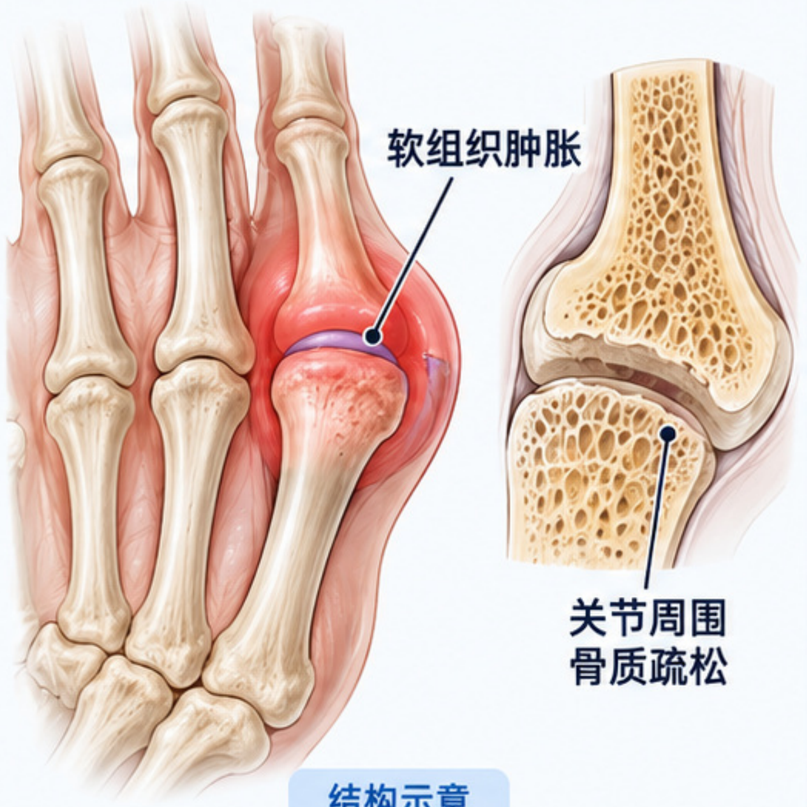
抗体阳性不是确诊

抗体阴性也不是排除

X线主要看结构损伤，早期可以正常

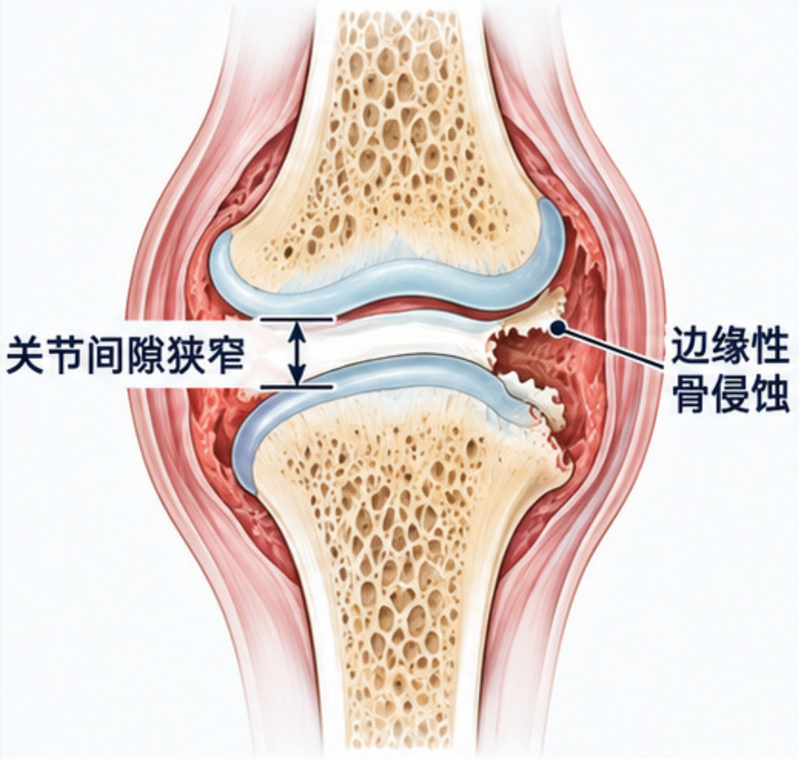
建立基线，结合病程解读

● 软组织肿胀、关节周围骨质疏松



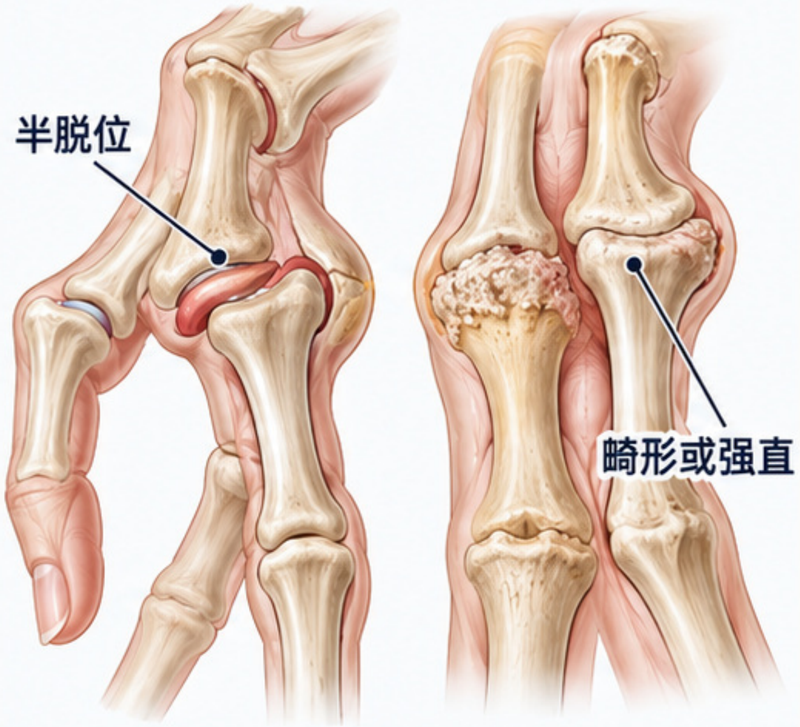
结构示意

● 关节间隙狭窄、边缘性骨侵蚀



结构示意

● 晚期可见半脱位、畸形或强直



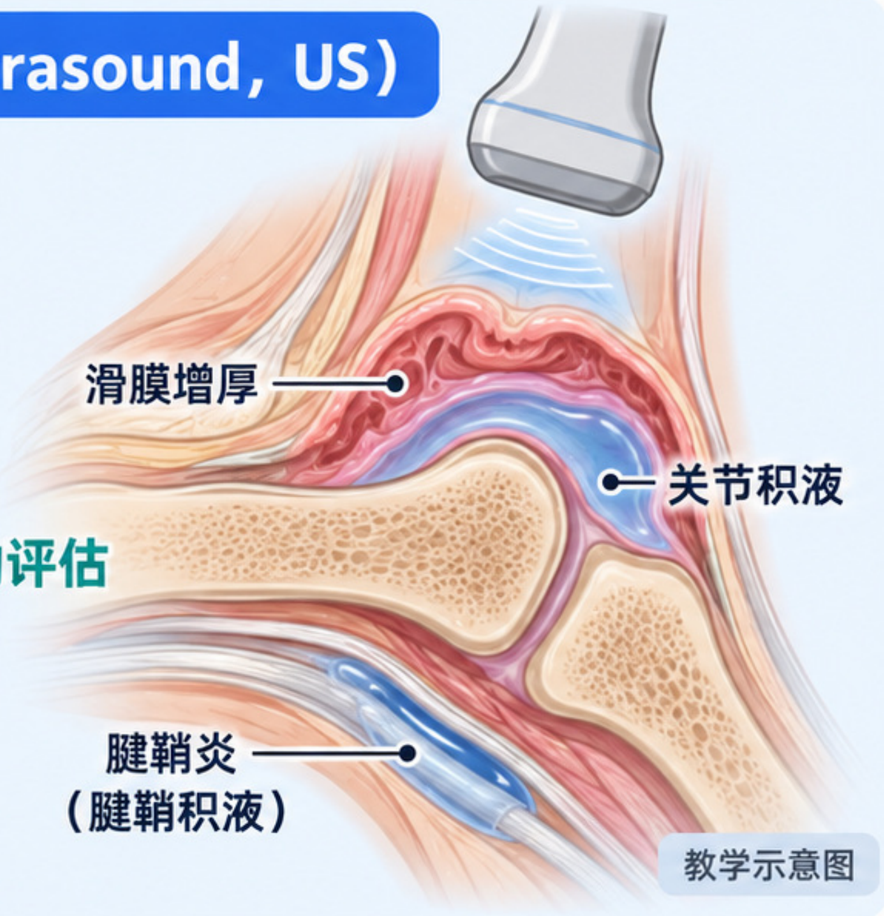
结构示意

超声与MRI补充X线看不到的信息

根据临床问题选择检查

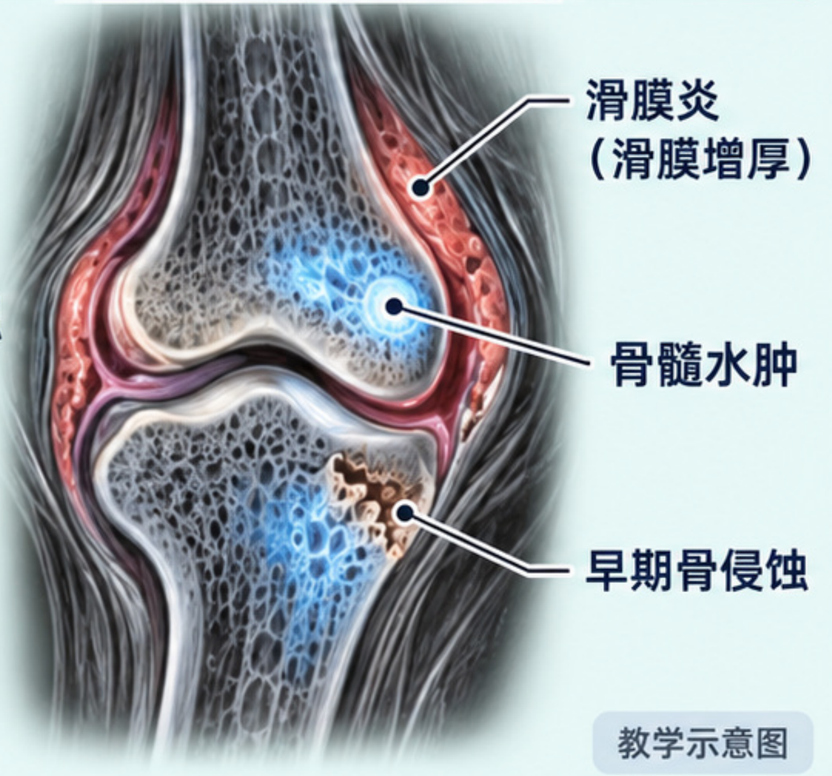
超声（Ultrasound，US）

- 滑膜增厚
- 积液
- 腱鞘炎
- 多普勒辅助评估活动性



MRI（Magnetic Resonance Imaging，MRI）

- 滑膜炎
- 骨髓水肿
- 早期骨侵蚀



影像增强证据，不能代替病史、查体与鉴别诊断

先满足入口条件，再使用分类标准

2010 ACR/EULAR标准不等同于临床诊断

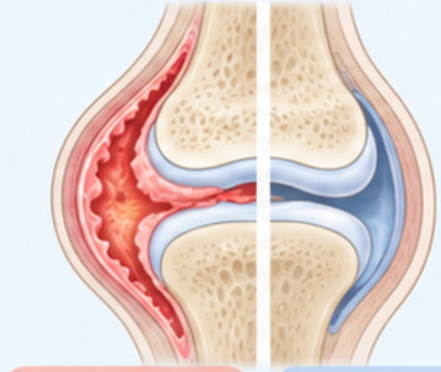
1 第一个入口条件

至少1个关节有
明确临床滑膜炎，
即肿胀



2 第二个入口条件

这种滑膜炎
不能由其他疾病
更好解释



3 按四个领域计分

- 受累关节数
- 血清学
（RF、ACPA）
- 急性期反应物
（CRP、ESR）
- 症状持续时间

4 总分判断

总分 ≥ 6/10

可分类为RA

来源：2010 ACR/EULAR分类标准

关节受累：分布与数量共同决定分值

A领域 | 0—5分

受累关节情况	分值
1个大关节	0分
2—10个大关节	1分
1—3个小关节	2分
4—10个小关节	3分
>10个关节且至少1个小关节	5分

DIP、第一CMC、第一MTP不计入。 | 按最高适用档计分，不相加。

其余三域：抗体、炎症指标和时间

B 0—3分 | C 0—1分 | D 0—1分

B 血清学 0—3分

RF与ACPA均阴性	0分
任一低滴度阳性	2分
任一高滴度阳性	3分

低滴度：>ULN且≤3×ULN
高滴度：>3×ULN
取较高档，不相加

C 炎症指标 0—1分

ESR和CRP均正常	0分
ESR或CRP异常	1分

D 症状时间 0—1分

＜6周	0分
≥6周	1分

ULN＝正常上限。

病例A：四域计分为7分

先排除更合理病因，再解释得分

病例摘要

女性，42岁，双侧第2、3掌指关节肿胀、压痛，共4个关节。

RF低滴度阳性，抗CCP阴性，CRP升高，症状持续3个月。

已确认临床滑膜炎，并排除更合理病因。

计分项目	本例情况及分值	
关节域	4个小关节受累	3分
血清学域	RF低滴度阳性	2分
炎症域	CRP升高	1分
病程域	≥6周	1分
总分	**3+2+1+1=7/10**	

结论 | 在满足入口条件的前提下，符合分类标准。

鉴别诊断先看模式，再找关键线索

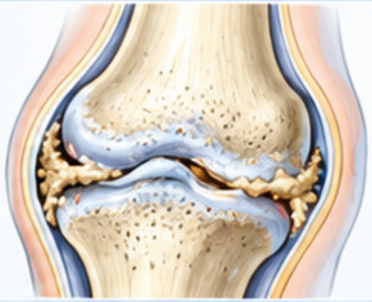
遇急性红肿热痛，先排除关节感染

关节感染是急症
遇急性红肿热痛，先排除关节感染

骨关节炎

- 机械性痛、
  DIP/第一CMC、
  骨性膨大

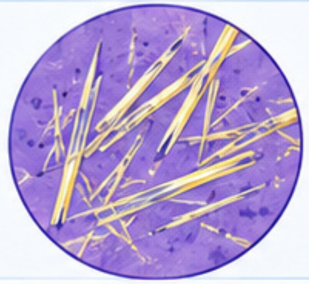




痛风

- 急性单/寡关节炎，
  关节液尿酸盐结晶
  有价值

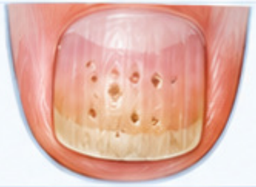




银屑病关节炎

- 看皮肤与甲

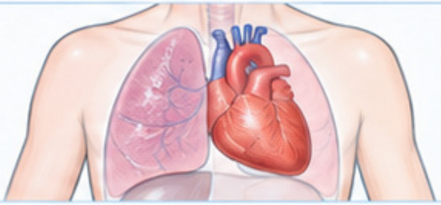




SLE

- 看全身线索





确诊之后，还要评估活动、功能与损伤

诊断名称不代表当前病情程度



炎症活动

肿胀与压痛关节、
ESR/CRP、整体评价



疾病活动评分

DAS28需选用并
保持一致的版本



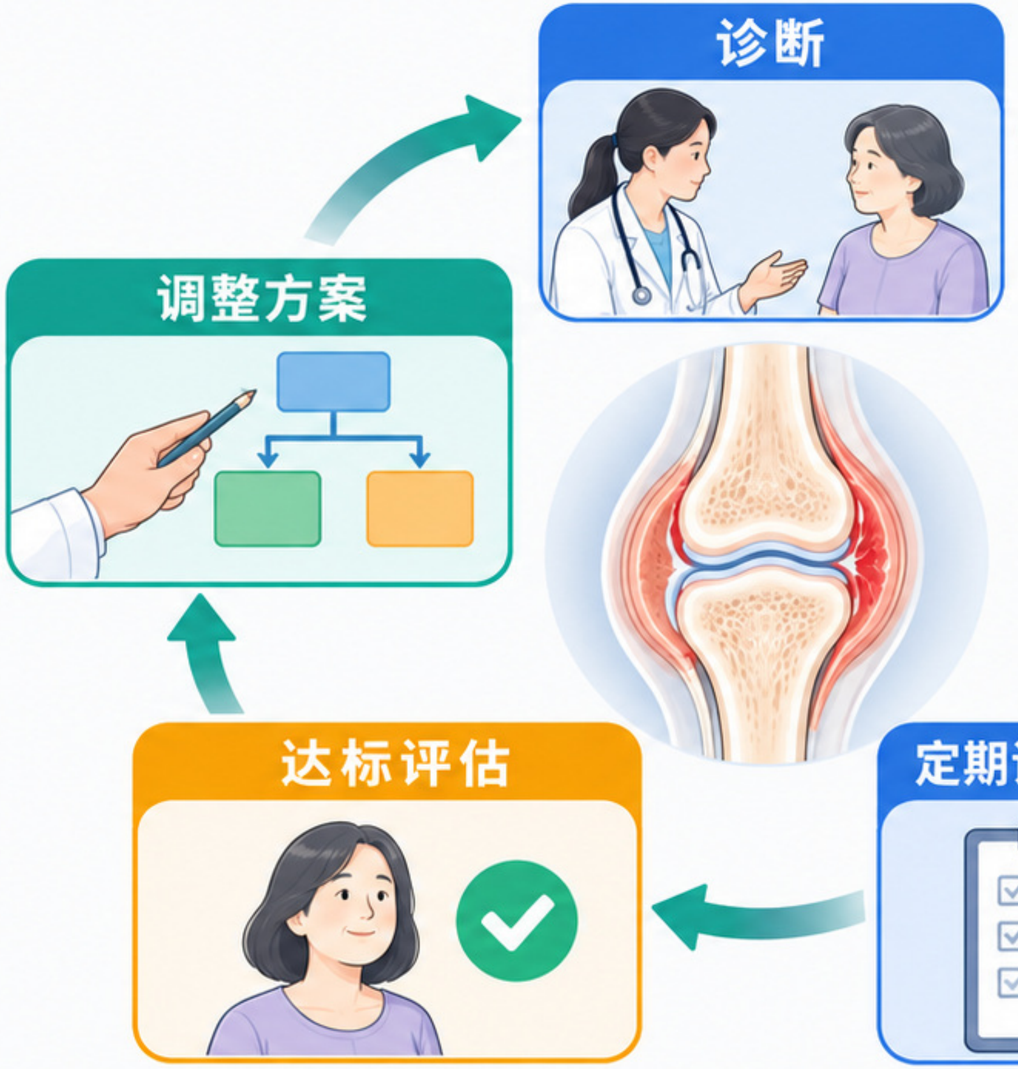
功能与结构

HAQ等量表评估功能；
影像评估结构损伤

治疗随访不能只看疼痛是否减轻。

治疗主线：早期、持续、达标

目标是缓解，或至少低疾病活动度



1 及时启动
适宜DMARD治疗

2 定期评估
疗效与安全性

3 未达标则依据
风险和患者因素
调整方案

对症治疗不能替代DMARDs

把缓解症状与疾病修饰区分开

NSAIDs



- 缓解疼痛与晨僵
- 不能阻止骨侵蚀
- 关注胃肠道、肾脏及心血管风险

糖皮质激素



- 部分患者可短期控制炎症
- 最低有效剂量、最短疗程，避免长期依赖
- 关注感染、骨质疏松等风险

两者均不能替代规范DMARD治疗。

MTX的首要安全记忆：每周，绝非每日

甲氨蝶呤是重要锚定药，需个体化选择



每周给药



绝非每日

常配合叶酸补充



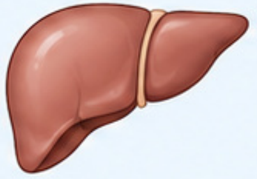
妊娠禁用

治疗前评估生育计划及禁忌证

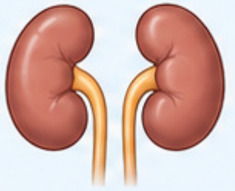
定期监测



血常规



肝功能



肾功能

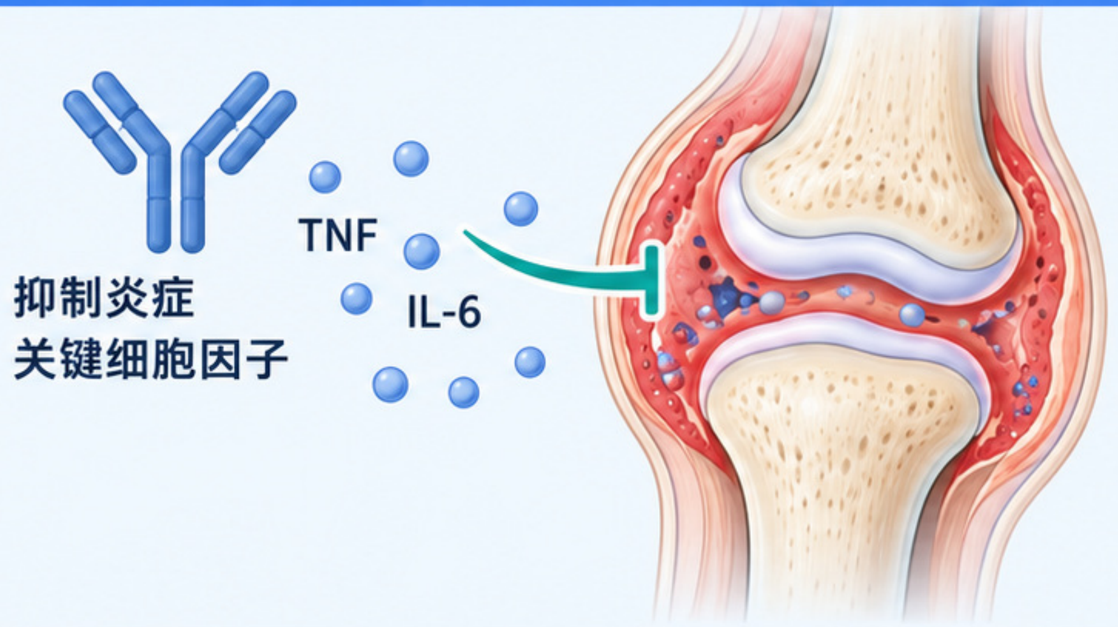
其他csDMARDs：

- 来氟米特
- 柳氮磺吡啶
- 羟氯喹
- 艾拉莫德

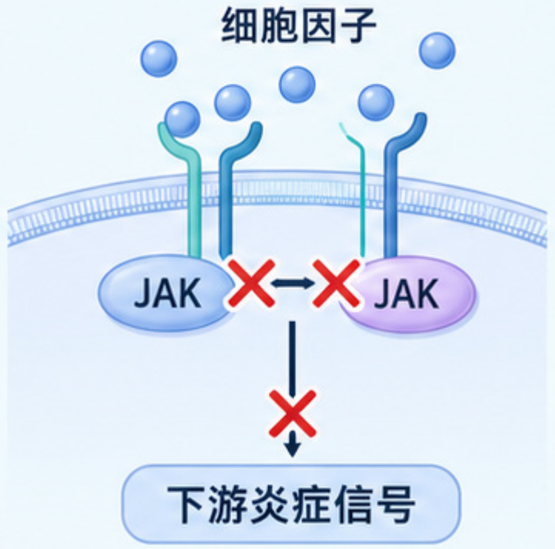
疗效不足时，考虑生物或靶向合成DMARDs

先评估既往疗效与个体风险

bDMARDs 如TNF、IL-6受体等靶向治疗



tsDMARDs 如JAK抑制剂，需综合获益风险



JAK抑制剂的主要风险

- 严重感染
- 血栓
- 心血管风险

治疗前筛查与治疗中监测

治疗前筛查
结核、乙肝等

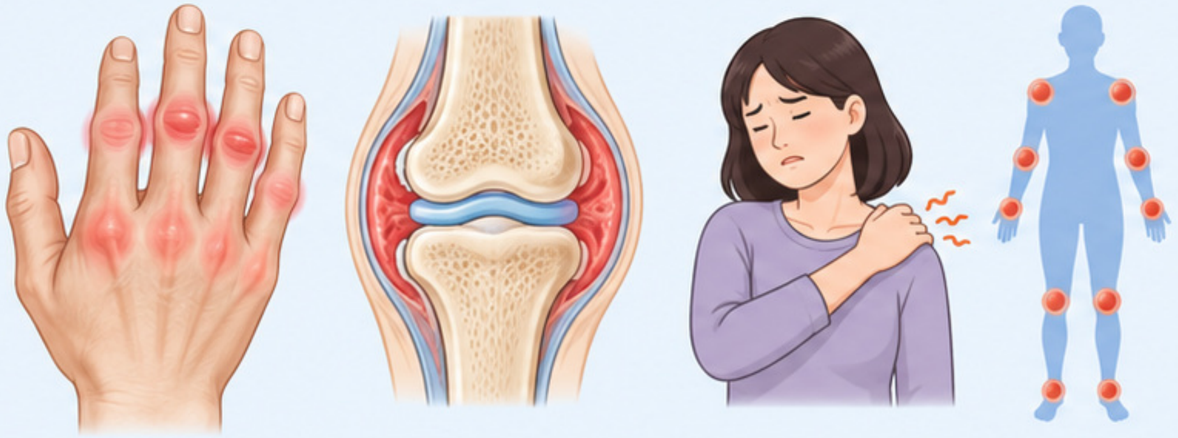
结核　乙肝

治疗中关注
感染及其他风险

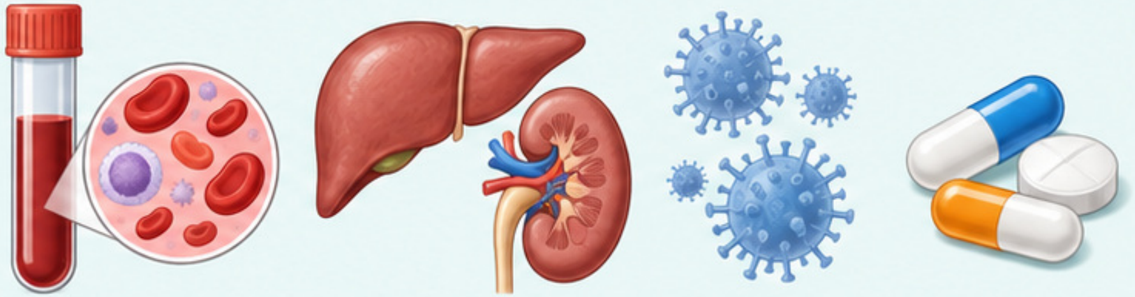
复诊同时回答两个问题：有效吗，安全吗？

用药后管理与起始处方同样重要

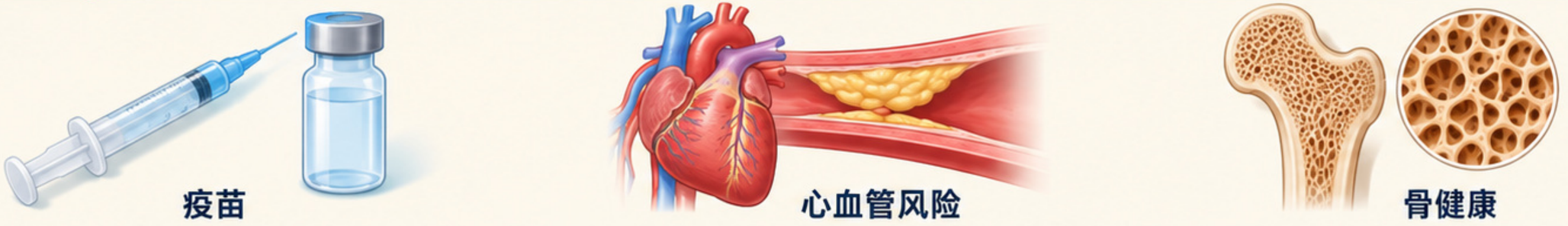
疗效 关节体征、晨僵、患者感受与疾病活动



安全 血常规、肝肾功能、感染和用药不良反应



长期 疫苗、心血管风险、骨健康；按具体药物安排复查



回到病例A：把诊断思路变成管理计划

下一步不只是开止痛药

1 完成基线评估



感染风险、血常规、
肝肾功能及适宜影像

2 共同制定治疗方案



讨论适宜的早期DMARD；
开展患者教育、合理活动
与功能康复

3 安排复诊与监测



评估疗效与安全性，
未达标时调整方案

早期规范治疗与长期管理需要患者参与。

课堂自测：四个常见误区

先回答，再说明理由

1. RF阴性，能排除RA吗？

2. 分类评分≥6分，可以省略鉴别诊断吗？

3. 疼痛缓解，就等于达标了吗？

4. MTX能按每日服用吗？

识别滑膜炎，解释证据，尽早规范治疗

带走四条诊疗主线

1. **识别**：典型分布与炎症性线索
2. **解释**：检查结果必须结合临床
3. **分类**：先满足入口条件，再进行四域计分
4. **治疗**：早期DMARD、达标治疗与安全随访

资料基础：
用户提供的《类风湿关节炎》课件

Aletaha et al., 2010

Fraenkel et al., 2021

Smolen et al., 2023